

老年物理治疗评估工具手册

Geriatric Physical Therapy Outcome Measures

姓名	_____	性别	☐ 男 ☐ 女
年龄	_____	诊断	_____
评估日期	_____	治疗师	_____

评估类型： ☐ 首次评估 ☐ 后续跟进（第 ____ 次）

本手册整合了国际通用、经验证适用于老年人群的主观与客观评估工具，
便于临床操作与治疗效果追踪。各量表均附有评分说明与临床意义解读。

目录

章节	内容	类型
一	病史记录	主观
二	NPRS 数字疼痛评定量表	主观
三	EQ-5D-5L 欧洲五维健康量表	主观
四	握力测试 (Handgrip Strength)	客观
五	SPPB 简易体能状况量表	客观
六	TUG 起立行走计时测试	客观
七	2MST 2分钟原地踏步测试 (居家适用)	客观
八-A	ODI Oswestry 功能障碍指数 (腰痛专用)	专项
八-B	QuickDASH 上肢功能评估	专项
八-C	ABC Scale 活动特异性平衡信心量表	专项
八-D	BBS Berg 平衡量表	专项
九	评估总结	汇总
附录	MCID 速查表 / Borg RPE / 运动处方 / 评估流程	参考

一、病史记录

主诉

起病时间：_____ 部位：_____ 性质：☐钝痛 ☐刺痛 ☐酸胀 ☐麻木 ☐其他_____

持续 / 间歇：☐持续 ☐间歇 加重因素：_____ 缓解因素：_____

现病史

既往史（可多选）

- ☐ 高血压
- ☐ 冠心病
- ☐ 骨质疏松
- ☐ 帕金森病
- ☐ 慢性肺病
- ☐ 认知障碍
- ☐ 其他：_____
- ☐ 糖尿病
- ☐ 心律失常
- ☐ 脑卒中
- ☐ 关节炎
- ☐ 视力/听力下降
- ☐ 泌尿系统疾病

跌倒史（过去 12 个月）

跌倒次数	☐ 0 次 ☐ 1 次 ☐ 2 次以上（____次）	受伤情况	☐ 无 ☐ 软组织伤 ☐ 骨折 ☐ 头部外伤
跌倒恐惧	☐ 无 ☐ 轻度 ☐ 中度 ☐ 重度（限制活动）	求助情况	☐ 可自行起身 ☐ 需他人协助

用药与手术史

长期用药：☐ 抗凝药 ☐ 降压药 ☐ 降糖药 ☐ 镇静/安眠药 ☐ 镇痛药 ☐ 其他：_____

手术史：_____

生活与功能状况

居住情况	☐ 独居 ☐ 与家人同住 ☐ 机构	辅助器具	☐ 无 ☐ 拐杖 ☐ 助行器 ☐ 轮椅
运动习惯	☐ 无 ☐ 偶尔 ☐ 规律（____次/周）	吸烟/饮酒	☐ 无 ☐ 吸烟 ☐ 饮酒
既往康复	☐ 无 ☐ 有：_____	患者期望	_____

过敏史与家族史

过敏史：☐ 无 ☐ 药物（_____） ☐ 食物/其他（_____）
家族史：☐ 无特殊 ☐ 有：_____（如骨质疏松、心脑血管病、退行性神经病等）

红旗征筛查（任一阳性需警惕，必要时转介）

- ☐ 夜间剧痛 / 休息痛
- ☐ 不明原因体重下降 > 5 kg
- ☐ 近期外伤 / 跌倒史
- ☐ 持续发热 / 盗汗
- ☐ 肠道 / 膀胱功能改变
- ☐ 既往恶性肿瘤史
- ☐ 进行性肌无力 / 萎缩
- ☐ 凝血异常 / 长期抗凝

神经系统症状

麻木/刺痛	☐ 无 ☐ 上肢 ☐ 下肢 ☐ 其他_____	肌力下降	☐ 无 ☐ 上肢 ☐ 下肢
头晕/眩晕	☐ 无 ☐ 偶发 ☐ 频发 ☐ 体位相关	视力变化	☐ 无 ☐ 复视 ☐ 模糊
言语/吞咽	☐ 无 ☐ 有：_____	步态异常	☐ 无 ☐ 拖步 ☐ 摇摆

日常生活活动（ADL）基线

项目	独立	需部分协助	完全依赖
进食	☐	☐	☐
洗澡	☐	☐	☐
穿衣	☐	☐	☐
如厕	☐	☐	☐
床椅转移	☐	☐	☐
平地行走	☐	☐	☐
上下楼梯	☐	☐	☐
购物/做饭（IADL）	☐	☐	☐

居家环境与康复目标

居家风险	☐ 地毯/门槛易绊倒 ☐ 卫生间无扶手 ☐ 照明不足 ☐ 楼梯陡峭 ☐ 无
SMART 目标	_____

二、数字疼痛评定量表 (NPRS)

请患者用 0 – 10 的数值描述疼痛程度。0 = 无痛，10 = 所能想象的最剧烈疼痛。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无痛					中度					最剧烈

时间点	疼痛评分 (0 – 10)
现在 (静息时)	
过去24小时内最轻	
过去24小时内最重	
活动时	

疼痛部位标记图

请在图中标记疼痛部位 (阴影 = 疼痛，X = 最痛点)：

前 面	后 面
(患者在此区域标注疼痛位置)	(患者在此区域标注疼痛位置)

MCID：疼痛降低 ≥ 2 分视为有效改善。

三、欧洲五维健康量表 (EQ-5D-5L)

请在以下每个维度中，勾选最能描述您今天健康状况的那一项：

行动能力

- ☐ 我可以四处走动，没有困难
- ☐ 我四处走动有一些困难
- ☐ 我四处走动有中度的困难
- ☐ 我四处走动有严重的困难
- ☐ 我因健康问题无法四处走动

自我照顾

- ☐ 我自己洗澡或穿衣没有困难
- ☐ 我自己洗澡或穿衣有一些困难
- ☐ 我自己洗澡或穿衣有中度的困难
- ☐ 我自己洗澡或穿衣有严重的困难
- ☐ 我无法自己洗澡或穿衣

日常活动

- ☐ 我进行日常活动没有困难（如工作、学习、家务、休闲活动）
- ☐ 我进行日常活动有一些困难
- ☐ 我进行日常活动有中度的困难
- ☐ 我进行日常活动有严重的困难
- ☐ 我无法进行日常活动

疼痛或不适

- ☐ 我没有疼痛或不适
- ☐ 我有一些疼痛或不适
- ☐ 我有中度的疼痛或不适
- ☐ 我有严重的疼痛或不适
- ☐ 我有非常严重的疼痛或不适

焦虑或抑郁

- ☐ 我没有焦虑或抑郁
- ☐ 我有一点焦虑或抑郁
- ☐ 我有中度的焦虑或抑郁
- ☐ 我有严重的焦虑或抑郁
- ☐ 我有非常严重的焦虑或抑郁

EQ-5D-5L 五维组合可转化为健康效用指数（0 - 1）。MCID：效用值 ↑ 0.05 - 0.08。

四、握力测试 (Handgrip Strength)

仪器：Jamar 或同等液压握力计，调整至第二档位。

体位：坐位，肩内收中立位，肘屈 90°，前臂中立位，腕 0 – 30° 背伸。

方法：左右手交替，各测 3 次，每次间隔 ≥ 30 秒。鼓励最大用力。

	第 1 次 (kg)	第 2 次 (kg)	第 3 次 (kg)	最佳值 (kg)
左手				
右手				
双手均值	—	—	—	

参考值 (亚洲人群 AWGS 2019)

性别	肌少症风险截断值	备注
男性	< 26 kg	
女性	< 18 kg	

MCID：握力增加 ≥ 5 – 6 kg 视为有临床意义的改善。

五、简易体能状况量表（SPPB）

SPPB 包含三个子测试，总分 0 – 12 分。≤ 8 分提示衰弱 / 高跌倒风险。

客观测试通用安全守则

- 治疗师全程站于患者侧后方近身保护，防止跌倒。
- 出现胸痛胸闷、严重呼吸困难、头晕/共济失调、大汗苍白、 $SpO_2 < 85\%$ 或患者要求停止 → 立即终止测试。
- 耐力测试（2MST）前：静息 SBP > 180 或 DBP > 110、 $SpO_2 < 90\%$ → 暂缓。

A. 站立平衡测试

要求：患者不使用辅助器具站立。每项计时最多 10 秒。

测试姿势	能否完成	计时（秒）	得分
1. 双脚并拢站立	☐ 能 / ☐ 不能		☐ 0分 / ☐ 1分
2. 半串联站立 （一脚脚跟放在另一脚大脚趾旁）	☐ 能 / ☐ 不能		☐ 0分 / ☐ 1分
3. 串联站立 （一脚脚跟紧贴另一脚脚尖）	☐ 能 / ☐ 不能	10秒=2分 3 – 9.99秒=1分 <3秒=0分 记录秒数：_____ 秒	☐ 2分 ☐ 1分 ☐ 0分

如姿势 1 不能 → 0 分停止；如姿势 2 不能 → 1 分，进入步行测试。

B. 4米步行速度测试

要求：以平常速度行走 4 米（可用辅助器具），测 2 次，取较快一次。

	第 1 次			第 2 次	
步行时间（秒）					
时间	≤ 4.82 秒	4.83 – 6.20 秒	6.21 – 8.70 秒	> 8.70 秒	不能
得分	4 分	3 分	2 分	1 分	0 分

步行速度得分：_____ 分

C. 5次坐站测试

要求：双手交叉抱于胸前，从标准椅子（座高约 43 – 45 cm）完全站起再坐下，重复 5 次，计时。

预备测试：先做 1 次看是否能独立完成。

能否完成?	☐ 能 完成时间：_____ 秒			☐ 不能 → 0 分	
时间	≤ 11.19 秒	11.20 – 13.69 秒	13.70 – 16.69 秒	16.70 – 59.99 秒	> 60 秒
得分	4 分	3 分	2 分	1 分	0 分

坐站测试得分：_____ 分

子测试	A. 平衡 (0 – 4)	B. 步行速度 (0 – 4)	C. 坐站 (0 – 4)	SPPB 总分 (0 – 12)
得分				

SPPB 解读

- 0 – 3 分：严重受限，跌倒高风险 • 4 – 6 分：中度受限
- 7 – 9 分：轻度受限 • 10 – 12 分：功能良好
- MCID: ≥ 1.0 分

六、起立行走计时测试 (TUG)

操作步骤

1. 患者坐在标准扶手椅（座高约 45 cm），背靠椅背。
2. 在椅子前方 3 米处地面放置标记物（胶带或锥桶）。
3. 指令：「我喊"开始"后，请您站起来，以安全且尽可能快的速度走到 3 米标记处，转身，走回椅子，再坐下。」
4. 计时从说"开始"到患者臀部再次接触椅面。
5. 先做 1 次练习，再做 1 – 2 次计时测试，取最佳成绩。
6. 患者可使用日常辅助器具（如拐杖）。

	时间（秒）	使用辅具?	备注
练习（不计分）		☐ 是 / ☐ 否	
计时 1		☐ 是 / ☐ 否	
计时 2（可选）		☐ 是 / ☐ 否	
最佳成绩			

解读标准

- < 10 秒：正常，可独立自由移动
- 10 – 19 秒：基本独立，但步行和平衡可能有轻度障碍
- ≥ 13.5 秒：跌倒风险增高
- ≥ 20 秒：明显移动障碍，需要干预
- ≥ 30 秒：严重功能障碍，日常生活需要协助

MCID：TUG 时间缩短 ≥ 2 – 3 秒视为有临床意义的改善。

七、2分钟原地踏步测试（2MST） — 居家适用

2MST 是 2MWT/6MWT

在空间受限（如居家）时的公认替代方案，仅需立足之地，用于评估有氧耐力与下肢耐力。源自 Senior Fitness Test。

场地与器材

- 立足之地即可（墙边或稳固椅旁），无需长走道。
- 秒表、墙面胶带或弹力带（用于标记抬膝高度）。
- 血压计、脉搏血氧仪、Borg 量表（RPE 6 – 20）。
- 稳固座椅 / 助行器供患者单手轻扶维持平衡（仅平衡，不借力上提）。

抬膝高度标记

取髌骨上缘与髂嵴之间中点的高度，在墙面贴胶带，或用弹力带系于两椅之间作参照。患者每次踏步需将一侧膝抬至此高度方计为有效步数。

测试前评估

指标	数值	备注
静息心率（HR）	_____ 次/分	正常 60 – 100
血压（BP）	_____ / _____ mmHg	静息 SBP > 180 暂缓
血氧饱和度（SpO ₂ ）	_____ %	如 < 90% 需谨慎
Borg RPE（静息）	_____ (6 – 20)	

操作指令

"请原地踏步 2 分钟，每次抬膝尽量达到标记高度。目标是 2 分钟内尽可能多地完成正确抬步次数。中途可放慢或停顿休息，但计时不停。准备好了吗？开始！"

- 计数：每完成一次达标抬膝计 1 步（通常计一侧，如右膝），记录 2 分钟总步数。
- 每 30 秒提示时间并标准化鼓励；2 分钟到 → "停！" 记录总步数。
- 测试者须站在患者侧后方保护，防止跌倒。

测试结果

2 分钟总步数	_____ 步	达标抬膝高度：_____ cm
---------	---------	-----------------

测试后评估

指标	数值	备注
心率（HR）	_____ 次/分	

指标	数值	备注
血压 (BP)	_____ / _____ mmHg	
SpO ₂	_____ %	如 < 88% 或下降 > 4% 需关注
Borg RPE (用力后)	_____ (6 – 20)	
Borg 呼吸困难	_____ (0 – 10)	改良 Borg 呼吸困难量表

年龄与性别参考值（步数，约第 50 百分位）

年龄段	男性（步）	女性（步）
60 – 69 岁	85 – 95	75 – 87
70 – 79 岁	75 – 87	65 – 80
80 – 89 岁	60 – 76	55 – 68

- 明显低于参考值 提示有氧耐力下降，跌倒与失能风险增高。
- MCID：研究尚不统一，建议以改善 ≥ 10 步（或基线的 ~10%）作为参考阈值。

八-A、Oswestry 功能障碍指数 (ODI) — 腰痛专用

请在每个问题中选择最符合您今天状况的一项。

1. 疼痛强度

- ☐ (0) 我目前不觉得疼痛。
- ☐ (1) 目前疼痛非常轻微。
- ☐ (2) 目前有中度疼痛。
- ☐ (3) 目前疼痛相当严重。
- ☐ (4) 目前疼痛非常严重。
- ☐ (5) 目前疼痛是所能想象的最严重的。

2. 自我照顾 (洗漱、穿衣等)

- ☐ (0) 我能正常照顾自己，不会引起疼痛加重。
- ☐ (1) 我能正常照顾自己，但会引起疼痛加重。
- ☐ (2) 自我照顾时疼痛，我需要缓慢小心地活动。
- ☐ (3) 自我照顾需要一些帮助，但大部分能自己完成。
- ☐ (4) 每天自我照顾的大部分需要帮助。
- ☐ (5) 无法自己穿衣、洗漱，需卧床。

3. 提物

- ☐ (0) 能提起重物且不加重疼痛。
- ☐ (1) 能提起重物但会加重疼痛。
- ☐ (2) 疼痛使我不能从地面提起重物，但位置方便时可以。
- ☐ (3) 疼痛使我不能提重物，但位置方便时能提轻至中等重量物品。
- ☐ (4) 我只能提起非常轻的物品。
- ☐ (5) 我不能提起或搬运任何物品。

4. 行走

- ☐ (0) 疼痛不影响行走距离。
- ☐ (1) 疼痛使我步行不超过 1.6 公里 (约 20 分钟)。
- ☐ (2) 疼痛使我步行不超过 800 米。
- ☐ (3) 疼痛使我步行不超过 400 米。
- ☐ (4) 我只能借助拐杖行走。
- ☐ (5) 我大部分时间卧床，上厕所都很困难。

5. 坐

- ☐ (0) 我能长时间坐在任何椅子上。
- ☐ (1) 我只能在我的专用椅子上长时间坐。
- ☐ (2) 疼痛使我坐不超过 1 小时。
- ☐ (3) 疼痛使我坐不超过 30 分钟。
- ☐ (4) 疼痛使我坐不超过 10 分钟。

- ☐ (5) 疼痛使我完全不能坐。

6. 站

- ☐ (0) 我能站任意长时间而不会加重疼痛。
☐ (1) 我能站任意长时间但会加重疼痛。
☐ (2) 疼痛使我站不超过 1 小时。
☐ (3) 疼痛使我站不超过 30 分钟。
☐ (4) 疼痛使我站不超过 10 分钟。
☐ (5) 疼痛使我完全不能站。

7. 睡眠

- ☐ (0) 疼痛不影响我的睡眠。
☐ (1) 疼痛偶尔影响睡眠。
☐ (2) 由于疼痛，睡眠时间不足 6 小时。
☐ (3) 由于疼痛，睡眠时间不足 4 小时。
☐ (4) 由于疼痛，睡眠时间不足 2 小时。
☐ (5) 疼痛使我完全无法入睡。

8. 性生活（如适用）

- ☐ (0) 性生活正常，不加重疼痛。
☐ (1) 性生活正常，但会加重疼痛。
☐ (2) 性生活接近正常，但明显疼痛。
☐ (3) 疼痛严重限制性生活。
☐ (4) 疼痛使性生活近乎不可能。
☐ (5) 疼痛使性生活完全不可能。

9. 社交生活

- ☐ (0) 社交生活正常，不加重疼痛。
☐ (1) 社交生活正常，但疼痛程度增加。
☐ (2) 疼痛对社交生活无显著影响，只限制较剧烈的活动（如运动）。
☐ (3) 疼痛限制了我的社交生活，我不能频繁外出。
☐ (4) 疼痛使我的社交生活仅限于家中。
☐ (5) 疼痛使我完全没有社交生活。

10. 出行/旅行

- ☐ (0) 我能外出旅行而不加重疼痛。
☐ (1) 我能外出旅行但疼痛会加重。
☐ (2) 疼痛虽重，但能完成 2 小时以上的行程。
☐ (3) 疼痛限制我只能完成 1 小时以内的行程。
☐ (4) 疼痛限制我只能完成 30 分钟以内的必要出行。
☐ (5) 除了去医院就诊，我不能外出。

ODI 评分

总分：_____ / 50

ODI% = (总分 ÷ 50) × 100 = _____ %

(如性生活项目不适用，则总分 ÷ 45 × 100)

解读：0 – 20% 轻度 | 21 – 40% 中度 | 41 – 60% 重度 | 61 – 80% 伤残 | 81 – 100% 卧床

MCID：ODI% 降低 ≥ 10 个百分点视为显著改善。

八-B、QuickDASH 上肢功能评估

请根据过去一周的状况回答。即使左右手程度不同，也请以整体功能作答。

困难程度（1=无困难，5=不能完成）

项目	1 无困难	2 有一点困难	3 中度困难	4 很大困难	5 不能完成
1. 拧开已拧紧的或新的瓶盖	☐	☐	☐	☐	☐
2. 做较重的家务（如擦地板、擦窗户）	☐	☐	☐	☐	☐
3. 提购物袋或公文包	☐	☐	☐	☐	☐
4. 清洗背部	☐	☐	☐	☐	☐
5. 用刀切食物	☐	☐	☐	☐	☐
6. 需要上肢力量或冲击力的娱乐活动（如打羽毛球、打网球）	☐	☐	☐	☐	☐

症状严重程度（过去一周）

项目	1 没有	2 轻微	3 中度	4 重度	5 极度
7. 上肢（肩、臂、手）疼痛程度？	☐	☐	☐	☐	☐
8. 当进行某项具体活动时，上肢的疼痛程度？	☐	☐	☐	☐	☐
9. 上肢的麻木或刺痛感（针刺样感觉）程度？	☐	☐	☐	☐	☐

影响（过去一周）

10. 上肢问题是否影响您的工作或日常活动？	☐ 没有影响 ☐ 轻度 ☐ 中度 ☐ 重度 ☐ 极度
11. 上肢问题是否影响您的睡眠？	☐ 没有影响 ☐ 轻度 ☐ 中度 ☐ 重度 ☐ 极度

评分

QuickDASH = [(各项分数之和 ÷ 项目数) - 1] × 25 = _____

（至少需完成 10/11 项才能计算）评分范围 0 - 100，越高表示障碍越严重。

MCID：减少 ≥ 10 - 15 分视为有临床意义的改善。

八-C、活动特异性平衡信心量表（ABC Scale）

请评估您完成以下各项活动时，对自己不会失去平衡有多大信心。

从 0%（毫无信心）到 100%（完全有信心）中选择。

序号	活动	信心程度（0 – 100%）
1	在屋内走动	
2	上或下楼梯	
3	弯腰从地上捡起拖鞋	
4	伸手去拿放在与眼同高架子上的小罐子	
5	踮起脚尖去拿高过头顶的物品	
6	站在椅子上够东西	
7	扫地	
8	走出家门，走向停在车道上的车	
9	进出轿车	
10	穿过停车场走向商场	
11	走上或走下斜坡	
12	在拥挤的商场里快步走过人群	
13	在人群中行走时被别人撞到	
14	扶着扶手踏上或踏下自动扶梯	
15	双手提着东西且不能扶扶手时踏上或踏下自动扶梯	
16	在结冰的或较滑的人行道上行走	

评分

ABC 得分 = 各项目评分的平均值 = _____ %

• < 67%：跌倒风险增高 • 50 – 80%：中等功能水平 • > 80%：高功能水平

MCID：提高 ≥ 10 个百分点视为有临床意义的改善。

八-D、Berg 平衡量表 (BBS)

BBS 是老年平衡功能评估的金标准量表，共 14 项，每项 0–4 分，总分 0–56 分。

指导语：请按指令完成以下动作，治疗师根据完成质量评分。需有人保护。

序号	测试动作	0	1	2	3	4	得分
1	从坐位到站立	☐	☐	☐	☐	☐	
2	从站立到坐位	☐	☐	☐	☐	☐	
3	坐位 ↔ 站立位转移	☐	☐	☐	☐	☐	
4	无支撑站立	☐	☐	☐	☐	☐	
5	无支撑坐位（双脚着地）	☐	☐	☐	☐	☐	
6	闭眼站立	☐	☐	☐	☐	☐	
7	双脚并拢站立	☐	☐	☐	☐	☐	
8	上肢前伸（测量前伸距离 cm）	☐	☐	☐	☐	☐	
9	从地面拾物	☐	☐	☐	☐	☐	
10	转身向后看	☐	☐	☐	☐	☐	
11	原地转身 360°	☐	☐	☐	☐	☐	
12	双脚交替踏台阶	☐	☐	☐	☐	☐	
13	一脚在前一脚在后（串联站姿）	☐	☐	☐	☐	☐	
14	单腿站立（记录支撑时间 秒）	☐	☐	☐	☐	☐	

评分标准：0 = 不能完成 | 1 = 需大量帮助 | 2 = 需少量帮助 | 3 = 独立完成但欠稳 | 4 = 正常独立完成

BBS 总分 _____ / 56

解读

- 0–20 分：平衡功能差，高跌倒风险（通常需轮椅）
- 21–40 分：平衡功能可接受，需辅助器具行走，中度跌倒风险
- 41–56 分：平衡功能良好，独立行走，低跌倒风险
- 跌倒风险截断值：< 45 分 提示跌倒风险增高（< 50 分亦有报告）

MCID：总分提高 ≥ 4 分（一般老年人群）/ ≥ 6 分（脑卒中后）视为有临床意义的改善。

提示：完成 BBS 约需 15–20 分钟。若时间有限，可优先使用 SPPB 平衡子测试 + TUG 作快速筛查。

九、评估总结

核心测试结果汇总

测试项目	首次评估 日期： ____	后续评估 日期： ____	变化	达到 MCID?
NPRS（疼痛 0 – 10）				☐ Y / ☐ N
EQ-5D-5L（效用值）				☐ Y / ☐ N
握力（最佳值 kg）				☐ Y / ☐ N
SPPB（总分 0 – 12）				☐ Y / ☐ N
TUG（秒）				☐ Y / ☐ N
2MST（2分钟原地踏步，步数）				☐ Y / ☐ N
BBS（总分 0 – 56）				☐ Y / ☐ N
专项测试： _____				☐ Y / ☐ N
专项测试： _____				☐ Y / ☐ N

跌倒风险综合分层

勾选以下任一阳性项；综合阳性项数定级。

☐ SPPB $\leq$ 8 分	☐ TUG $\geq$ 13.5 秒
☐ 步速 $<$ 1.0 m/s	☐ ABC $<$ 67%
☐ BBS $<$ 45 分	☐ 过去 12 个月跌倒 $\geq$ 2 次

综合跌倒风险等级： ☐ 低（0 项） ☐ 中（1 – 2 项） ☐ 高（ $\geq$ 3 项）

建议干预：☐ 平衡训练 ☐ 下肢力量训练 ☐ 辅具评估/调整 ☐ 居家环境改造转介 ☐ 药物复核（转医生） ☐ 跌倒预防宣教

临床印象

治疗目标

1. _____
2. _____
3. _____

治疗计划

☐ 门诊物理治疗 频率： _____ 次/周 预期疗程： _____ 周

☐ 家庭运动方案 ☐ 团体训练 ☐ 社区康复转介 ☐ 其他: _____

治疗师签名: _____ 日期: _____

附录一、MCID 与截断值速查表

量表/测试	评分范围	MCID	截断值/高风险阈值
NPRS（疼痛）	0 – 10	↓ ≥ 2 分	—
EQ-5D-5L（效用值）	0 – 1	↑ 0.05 – 0.08	—
握力（男）	kg	↑ 5 – 6 kg	< 26 kg 肌少症风险
握力（女）	kg	↑ 5 – 6 kg	< 18 kg 肌少症风险
SPPB	0 – 12	↑ ≥ 1.0 分	≤ 8 分 衰弱/高跌倒风险
TUG	秒	↓ 2 – 3 秒	≥ 13.5 秒 跌倒风险增高
2MST（2分钟原地踏步）	步数	↑ ≥ 10 步	明显低于同龄参考值提示耐力下降
BBS（Berg 平衡）	0 – 56	↑ ≥ 4 分	< 45 分 跌倒风险增高
ODI（腰痛）	0 – 100%	↓ ≥ 10%	> 40% 重度功能障碍
QuickDASH（上肢）	0 – 100	↓ 10 – 15 分	—
ABC Scale（平衡信心）	0 – 100%	↑ 10%	< 67% 跌倒风险

附录二、Borg 自觉用力评分（RPE 6 – 20）

分值	描述
6	毫不费力（安静休息水平）
8	极其轻松
9	非常轻松（可以轻松说话，如慢走）
11	轻松
13	有点困难（说话开始费力）
15	困难
17	非常困难（呼吸急促，只能简短说话）
19	极其困难（接近极限）
20	最大用力（完全力竭）

附录三、运动处方记录（FITT-VP 原则）

运动类型	强度 (RPE)	频率 (次/周)	时间 (min)	组数×次数	备注
有氧运动 （如步行、功率车）					
抗阻训练（下肢）					
抗阻训练（上肢）					
平衡训练					
柔韧性训练（牵伸）					

附录四、评估流程建议（首次评估约 40 – 50 分钟）

顺序	内容	大约时间
1	签署知情同意，采集病史（可由患者在候诊时完成问卷）	5 min
2	主观评估：NPRS + EQ-5D-5L（可由患者在候诊时完成）	5 min
3	SPPB（平衡 + 4米步行 + 5次坐站）	8 min
4	休息 2 – 3 分钟	3 min
5	TUG	3 min
6	握力测试	3 min
7	2分钟原地踏步测试（2MST，居家适用；前后测 HR、BP、SpO ₂ 、RPE）	5 min
8	Berg 平衡量表（如需详细平衡评估）	15 min
9	选做专项测试（ODI / QuickDASH / ABC / BBS）	5 – 10 min
10	评估总结与治疗目标沟通	5 min
合计		约 40 – 60 分钟